PSICOMETRÍA · GUÍA 2 · INFOGRAFÍA

¿La adaptación colombiana del LOT-R cumple las directrices de la ITC?

Paralelo entre el proceso de traducción y adaptación de la escala Life Orientation Test-Revised (optimismo disposicional) en cuidadores de pacientes con cáncer y las 20 directrices de la Comisión Internacional de Tests, segunda edición.

Artículo analizado: Valdelamar-Jiménez y Sánchez-Pedraza (2017), *Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 35*(2), 216-224.

Criterio: Muñiz, Elosua y Hambleton (2013), *Psicothema, 25*(2), 151-157.

5 Cumple	9 Cumple parcialmente	6 No cumple

20 directrices evaluadas · fortalezas en lo legal y lingüístico; vacío en la evidencia empírica

Lo que hicieron los autores

Siguieron el manual de traducción de la EORTC (Grupo de Calidad de Vida). El estudio se declara como la fase inicial de una validación posterior (p. 222).

1. **Permiso y ética** Autorización de los autores del LOT-R y aval del Comité de Ética del INC (p. 219)
2. **2 traducciones directas** Un médico y un psicólogo, independientes (p. 219)
3. **Consenso** Ítems 3, 7 y 9 con discrepancias; se crea versión preliminar (p. 219-220)
4. **2 traducciones inversas** Traductores nativos de inglés que no conocían la escala (p. 219)
5. **Prueba piloto** 21 cuidadores, entrevista individual, 5 a 7 min (p. 220-221)
6. **Versión final** Ítems 3, 7 y 9 reescritos; se verifica equivalencia semántica (p. 221-222)

1. Directrices previas

2 cumple · 3 parcial

DP1	CUMPLE	Obtener los permisos de quien tenga la propiedad intelectual del test.	"Previa solicitud de permiso los autores aceptaron la traducción y adaptación al español colombiano de la escala". `p. 219`
DP2	PARCIAL	Cumplir las leyes y prácticas profesionales sobre el uso de tests del país.	Reportan aprobación del Comité de Ética del Instituto Nacional de Cancerología y "asentimiento informado" de los participantes `p. 219-220`. No mencionan la normativa colombiana (p. ej., Ley 1090 de 2006, art. 50, sobre derechos de los participantes) ni el manejo de datos.
DP3	CUMPLE	Seleccionar el diseño de adaptación más adecuado.	Eligen y justifican el procedimiento de la EORTC, con traducciones directas e inversas y prueba piloto, para mantener la equivalencia semántica `p. 219`.
DP4	PARCIAL	Evaluar la relevancia del constructo en las poblaciones de interés.	Argumentan con literatura la importancia del optimismo en cuidadores `p. 218-219`, pero no evalúan si el constructo se entiende igual en cuidadores colombianos. Además citan que en población colombiana el LOT-R mostró estructura bidimensional con alfa de 0,58 en pesimismo `p. 218` y no discuten esa implicación.
DP5	PARCIAL	Evaluar la influencia de diferencias culturales o lingüísticas relevantes.	El piloto detectó problemas de comprensión con la forma negativa "casi nunca" `p. 221` y los autores reconocen que la población reveló sesgos de interpretación `p. 223`. No hubo un análisis previo y sistemático de diferencias culturales (escolaridad mediana de 7 años, estratos 1 a 3).

2. Directrices de desarrollo

3 cumple · 2 parcial

DD1	CUMPLE	Asegurar con expertos cualificados que se consideren diferencias lingüísticas, psicológicas y culturales.	Traducción directa por dos profesionales (Medicina y Psicología) con fluidez en inglés y experiencia en medición; traducción inversa por dos traductores nativos de inglés `p. 219`. Falta un comité externo independiente; el consenso lo hizo el mismo equipo investigador.
DD2	CUMPLE	Usar diseños y procedimientos racionales apropiados para la población.	Proceso iterativo: dos traducciones independientes, consenso, retrotraducción, piloto y revisión final `p. 219-222`. No se apoyan solo en la traducción inversa, riesgo que Muñiz et al. (2013, p. 152) advierten.
DD3	CUMPLE	Dar evidencias de que instrucciones e ítems tienen significado similar en las poblaciones.	Las tablas 1 y 2 muestran ítem por ítem la versión original, las traducciones y la retrotraducción `p. 220`; la instrucción no presentó dificultades `p. 219`; se verificó la equivalencia semántica final `p. 222`. La evidencia es solo cualitativa.
DD4	PARCIAL	Dar evidencias de que formato, escala de respuesta, corrección y aplicación son adecuados.	Se conserva la escala de 0 a 4 `p. 222`. Siete cuidadores tuvieron dificultad para elegir la opción de respuesta en los ítems 7 y 9 `p. 221`. No se evalúan las reglas de corrección (ítems inversos y de relleno) ni la aplicación autoadministrada frente a la entrevistada.
DD5	PARCIAL	Hacer estudios piloto con análisis de ítems, fiabilidad y validez.	Hubo piloto con 21 cuidadores, acorde a la EORTC `p. 220`, pero fue cualitativo: no reportan análisis de ítems, fiabilidad ni validez de la versión colombiana.

3. Directrices de confirmación

4 no cumple

DC1	NO CUMPLE	Definir la muestra y usar un tamaño suficiente para los análisis empíricos.	La muestra piloto está bien descrita (tabla 3) `p. 221`, pero 21 personas, en su mayoría de Bogotá y de una sola institución, no permiten análisis empíricos.
DC2	NO CUMPLE	Dar información empírica sobre equivalencia de constructo, método e ítems.	Solo se establece equivalencia semántica por consenso. No hay análisis factorial, invarianza ni funcionamiento diferencial de los ítems.
DC3	NO CUMPLE	Recoger evidencias de fiabilidad y validez de la versión adaptada.	Solo citan alfas de otras versiones (0,65 a 0,80) `p. 218`. La validación queda para "estudios futuros" `p. 222-223`.
DC4	NO CUMPLE	Establecer la comparabilidad de puntuaciones entre poblaciones.	No se aplicó la escala para obtener puntuaciones ni se hicieron diseños de equiparación.

4. Directrices de aplicación

2 parcial

DA1	PARCIAL	Preparar materiales e instrucciones que minimicen diferencias culturales y lingüísticas.	La versión final (tabla 4) trae instrucción y escala en español colombiano `p. 222`, ajustadas según el piloto. No hay manual de aplicación.
DA2	PARCIAL	Especificar las condiciones de aplicación para todas las poblaciones.	Describen el piloto: individual, sin el paciente presente, en el servicio, dirigido por una investigadora, de 5 a 7 minutos `p. 220-221`. No fijan condiciones estandarizadas para usos futuros.

5. Puntuación e interpretación

2 no cumple

DPI1	NO CUMPLE	Interpretar diferencias entre grupos con la información demográfica pertinente.	No se reportan puntuaciones, por lo que no hay interpretación de diferencias entre grupos.
DPI2	NO CUMPLE	Comparar puntuaciones solo en el nivel de invarianza demostrado.	No hay estudio de invarianza. Afirman que el LOT-R mantiene "propiedades psicométricas equivalentes" en otros idiomas `p. 219`, algo que no se ha comprobado para esta versión.

6. Documentación

2 parcial

DOC1	PARCIAL	Documentar técnicamente los cambios y la evidencia de equivalencia entre versiones.	Documentan con detalle cada cambio y su razón (tablas 1, 2 y 4) `p. 220-222`. Falta la evidencia de equivalencia métrica.
DOC2	PARCIAL	Dar documentación a los usuarios para un uso correcto del test.	Publican la versión final con su instrucción `p. 222`, pero sin indicar qué ítems se invierten ni cuáles son de relleno en esta versión, y sin normas de interpretación.

En el artículo de Muñiz et al. (2013, p. 155) las directrices de documentación aparecen con los códigos DC1 y DC2, iguales a los de confirmación. Aquí se nombran DOC1 y DOC2 para distinguirlas.

Análisis crítico: ¿se puede usar esta versión del LOT-R?

FORTALEZAS

- Permiso de los autores y aval ético.
- Procedimiento iterativo con traductores independientes, sin confiar solo en la retrotraducción.
- Participación de la población objetivo, que permitió reconocer y corregir sesgos de interpretación (p. 223).
- Documentación transparente de cada cambio.

LIMITACIONES

- No hay datos de fiabilidad, validez ni equivalencia de la versión colombiana.
- Muestra pequeña, de una sola institución y casi toda de Bogotá.
- Los ítems negativos (3, 7 y 9) fueron confusos; el problema puede afectar la estructura factorial, como sugiere el alfa de 0,58 en pesimismo de otra versión aplicada en Colombia (p. 218).
- No se evalúa la escala con personas de baja escolaridad, pese a una mediana de 7 años.

USO RECOMENDADO

Esta versión sirve como punto de partida para investigación. Todavía no es apropiada para tomar decisiones clínicas sobre cuidadores ni para comparar sus puntuaciones con las de otros países, porque las directrices de confirmación (DC1 a DC4) y de interpretación (DPI1, DPI2) siguen pendientes.

Conclusión: la adaptación logró equivalencia lingüística y cultural, pero no métrica. Muñiz et al. (2013, p. 153) señalan que el objetivo es la máxima equivalencia lingüística, cultural, conceptual y métrica posible, y en este estudio la equivalencia métrica no se evaluó.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2006). *Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.*

Muñiz, J., Elosua, P. y Hambleton, R. K. (2013). Directrices para la traducción y adaptación de los tests: segunda edición. *Psicothema, 25*(2), 151-157. https://doi.org/10.7334/psicothema2013.24

Valdelamar-Jiménez, J. y Sánchez-Pedraza, R. (2017). Traducción y adaptación transcultural de la escala Life Orientation Test-Revised para medir optimismo disposicional en cuidadores de pacientes con cáncer en Colombia. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 35*(2), 216-224. https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v35n2a06